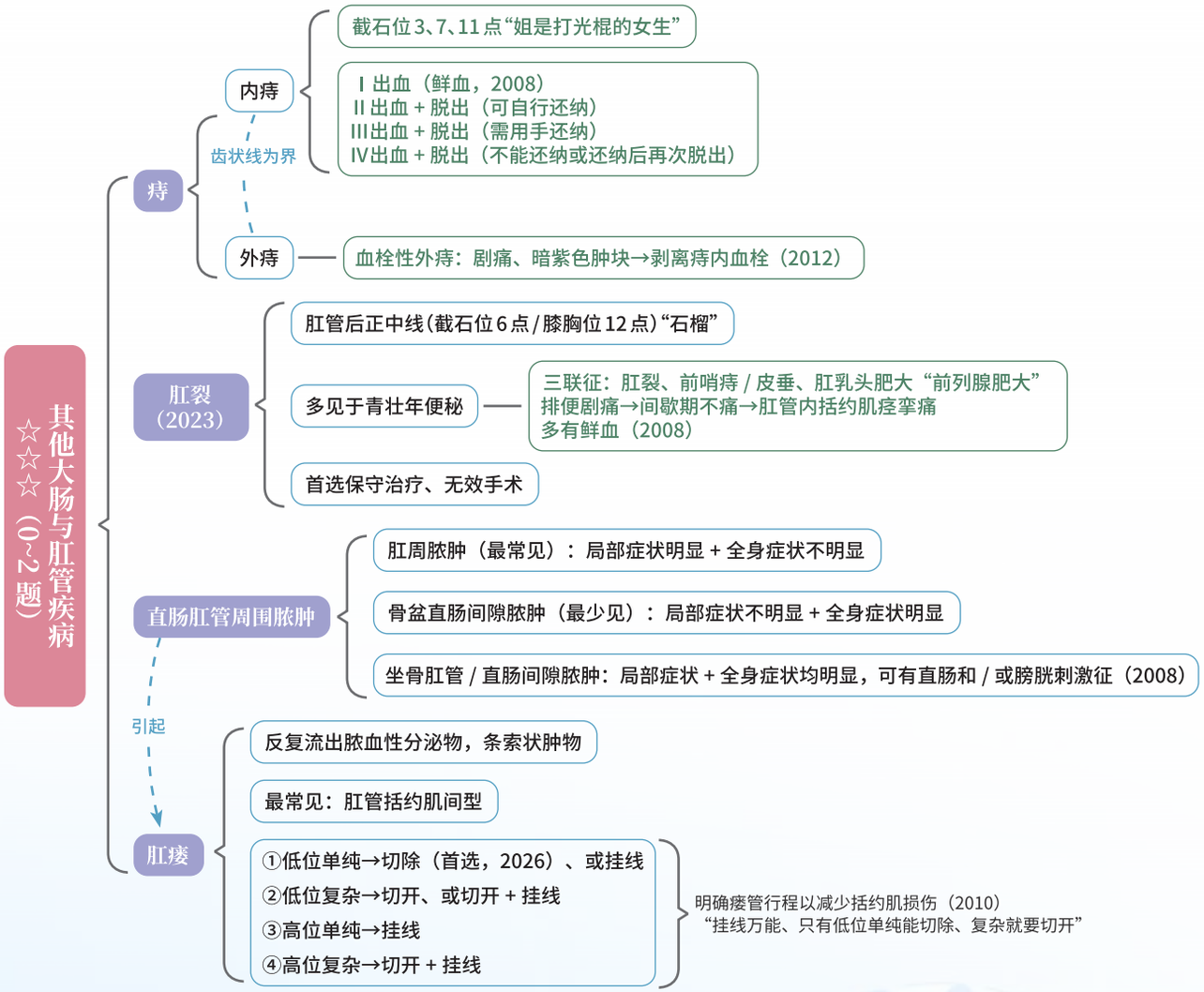

其他大肠与肛管疾病
☆☆☆（0~2题）
痔
内痔
齿状线为界
外痔
截石位3、7、11点“姐是打光棍的女生”
Ⅰ出血（鲜血，2008）
Ⅱ出血＋脱出（可自行还纳）
Ⅲ出血＋脱出（需用手还纳）
Ⅳ出血＋脱出（不能还纳或还纳后再次脱出）
血栓性外痔：剧痛、暗紫色肿块→剥离痔内血栓（2012）
肛裂（2023）
肛管后正中线（截石位6点/膝胸位12点）“石榴”
多见于青壮年便秘
三联征：肛裂、前哨痔/皮垂、肛乳头肥大“前列腺肥大”
排便剧痛→间歇期不痛→肛管内括约肌痉挛痛
多有鲜血（2008）
首选保守治疗、无效手术
直肠肛管周围脓肿
肛周脓肿（最常见）：局部症状明显＋全身症状不明显
骨盆直肠间隙脓肿（最少见）：局部症状不明显＋全身症状明显
坐骨肛管/直肠间隙脓肿：局部症状＋全身症状均明显，可有直肠和/或膀胱刺激征（2008）
引起
肛瘘
反复流出脓血性分泌物，条索状肿物
最常见：肛管括约肌间型
①低位单纯→切除（首选，2026）、或挂线
②低位复杂→切开、或切开＋挂线
③高位单纯→挂线
④高位复杂→切开＋挂线
明确瘘管行程以减少括约肌损伤（2010）
“挂线万能、只有低位单纯能切除、复杂就要切开”